

# Relatório de Auditoria EvidentiApp

Gerado em: 03/03/2026

---

## Resumo

---

O estudo foi delineado para investigar o **consumo de alimentos ultraprocessados** (AUP) e identificar fatores sociodemográficos, comportamentais e nutricionais associados em escolares da rede pública de Caxias do Sul, RS. A justificativa reside no **aumento global da obesidade infantil e na transição nutricional brasileira**, onde alimentos de alta densidade energética e baixa qualidade nutricional ganham espaço na dieta de crianças e adolescentes.

A metodologia consistiu em um estudo transversal com uma amostra inicial de 1.309 escolares (6 a 16 anos). A coleta de dados ocorreu entre 2015 e 2016, utilizando **questionários autorreferidos para avaliar o consumo alimentar (baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira) e medidas antropométricas (peso e altura) para calcular o IMC**. A análise estatística empregou a regressão de Poisson com variância robusta para identificar as Razões de Prevalência (RP).

Os resultados brutos revelaram uma prevalência alarmante: **69,7% dos escolares consumiam pelo menos um alimento ultraprocessado diariamente**. Após o ajuste estatístico, **os fatores que permaneceram associados ao maior consumo foram: levar ou comprar lanche para a escola (aumento de 9% na prevalência), realizar o lanche da manhã (aumento de 12%) e o lanche da noite (aumento de 22%)**. Por outro lado, ter recebido aconselhamento nutricional em algum momento da vida foi associado a uma **redução de 15% no consumo**.

Os autores concluem que o **consumo de ultraprocessados é elevado e está intrinsecamente ligado aos hábitos de lanches intermediários**. Eles sugerem que intervenções de educação nutricional e políticas públicas nas escolas são urgentes para mitigar esse cenário e prevenir doenças crônicas não transmissíveis precoces.

Do ponto de vista prático, o estudo reforça que o ambiente escolar e os momentos de lanche são os principais "gargalos" nutricionais. No entanto, a natureza transversal do estudo impede a afirmação de que levar o lanche *causa* o consumo de AUP, apenas que esses eventos coexistem na amostra estudada.

## Visão Geral (PICO)

---

- **P (População):** 1.128 escolares (amostra final com dados completos) de 6 a 16 anos, matriculados na rede municipal de ensino de Caxias do Sul-RS.
- **I (Intervenção/Exposição):** Consumo de alimentos ultraprocessados (pelo menos um item no dia), medido por questionário de autorrelato (QUADA-3).
- **C (Comparação):** Escolares que não consumiram ultraprocessados ou que não apresentavam os fatores de risco (ex: não levavam lanche, não faziam lanche da noite).
- **O (Outcomes/Desfechos):** Prevalência de consumo de AUP e sua associação com variáveis socioeconômicas, estado nutricional (IMC/Idade) e hábitos comportamentais.

## Destaques Encontrados

*"O consumo alimentar foi autorreferido pelo escolar, desta forma pode haver alguma variação de consumo quanto ao dia da semana."*

**Pág. 9:** Reconhecimento explícito **do viés de memória e de relato, inerente a questionários subjetivos.**

*"Identificou-se elevada prevalência de consumo de alimentos ultraprocessados entre os escolares (69,7%)."*

**Pág. 1:** Dado central que **sustenta a relevância epidemiológica do estudo.**

*"O estudo pode ter subestimado o real consumo de alimentos ultraprocessados. Por exemplo, o pão foi classificado como um alimento processado, contudo não foi questionada a origem do pão."*

**Pág. 9:** Insight crítico sobre a dificuldade de classificar alimentos pela regra NOVA sem detalhamento industrial.

## Revisão Detalhada

**Racional:** O estudo **busca entender por que crianças consomem tantos ultraprocessados, focando no ambiente escolar e familiar.** A plausibilidade biológica é clara: **o consumo de AUP está ligado ao excesso de peso e doenças metabólicas.**

**Objetivo:** Analisar a prevalência e os fatores associados ao consumo de AUP em uma amostra específica do Sul do Brasil.

**Métodos (Auditoria):** O desenho **transversal é adequado para medir prevalência, mas fraco para causalidade.** A amostragem foi semiprobabilística por conglomerados, o que é bom, mas houve uma perda de 13,8% da amostra (de 1.309 para 1.128), o que pode introduzir **viés de seleção** se os que não responderam tivessem hábitos muito diferentes. O uso do QUADA-3 (validado) é um ponto positivo, mas o autorrelato em crianças de 6 anos é altamente questionável sem supervisão parental rigorosa.

**Resultados (Fact-Checking):** O dado mais robusto é a prevalência de 69,7%. Curiosamente, **o excesso de peso não foi associado ao consumo de AUP na análise ajustada ( $p=0,21$ )**. Isso é um "balde de água fria" na hipótese simplista de que AUP causa obesidade de forma direta e imediata nesta amostra, **sugerindo que outros fatores (genética, atividade física) ou o tempo de exposição ainda não foram capturados.**

**Conclusão dos Autores vs Realidade:** Os autores focam na necessidade de educação nutricional. No entanto, os dados mostram que o "aconselhamento nutricional" (uma variável vaga: "já recebeu alguma dieta na vida?") teve um efeito protetor. Isso pode ser um viés de causalidade reversa: crianças que já tinham problemas de saúde ou pais mais preocupados buscaram ajuda e, por isso, comem menos AUP. **A realidade é que o estudo mostra uma correlação, não uma solução definitiva.**

## Auditoria Metodológica

---

- **Grau de Confiança:** Moderado-Baixo. (Amostra grande, mas desenho transversal e dados autorreferidos limitam a força das evidências).
- **Viés de Seleção?** Possível. A exclusão de escolas rurais e pequenas, além da perda de 181 participantes por dados incompletos, limita a generalização.
- **Viés de Aferição?** Alto. O autorrelato de crianças sobre o que comeram no dia anterior é propenso a erros de memória e ao desejo de agradar o pesquisador.
- **Viés de Confusão?** Controlado parcialmente. Os autores usaram modelo hierárquico, mas variáveis importantes como "nível de atividade física" ou "disponibilidade de cantinas nas escolas" não foram detalhadas.
- **Aplicabilidade Prática?** Alta para gestão pública local, mas deve ser lida com cautela por clínicos, pois a associação entre **AUP e IMC não foi estatisticamente significativa neste estudo.**